

SENTETİK ÖRNEK HASTANESİ
YOĞUN BAKIM EPİKRİZ RAPORU

Adı - Soyadı : ÖRNEK HASTA BİR Prot / Dosya No : 99001 / 700001

TC Kimlik No : 11111111111

Cinsiyeti - Yaş : ERKEK - 64

D.Tarihi : 12.03.1961

Kurum : ÖZEL

Bölüm Adı : Genel Yoğun Bakım Yatış Tarihi : 05.04.2023

Çıkış Tarihi : 13.04.2023

Taburcu Şekli : Şifa ile taburcu

Kesin Tanı : Pnömozeptis, akut böbrek yetmezliğı, KOAH

Apache II skoru: 22

tanısal ölüm oranı %42

Bilinen KOAH ve hipertansiyon tanılı hasta, nefes darlığı ve ateş ile acile başvurdu; solunum yetmezliğı ve pnömozeptis nedeniyle yoğun bakıma alındı, entübe edildi. Sağ subklaviyen santral venöz kateter yerleştirildi, invaziv ve noninvaziv monitörizasyon sağlandı.

05.04.2023 1.GÜN

Pnömozeptis, akut böbrek yetmezliğı ve solunum yetmezliğı tanılarıyla izlenen hastanın genel durumu kötü, GKS 7, pupiller izokorik, IR +/- . Entübe, basınç kontrol modunda (FİO2 %90, RR 16, PEEP 6) mekanik ventilatör desteğinde; dinlemekle her iki akciğer solunum sesleri kaba ve bilateral azalmış. TA 110/60 mmHg, nabız 112/dk, ateş 38.4 C. Laboratuvar: lökosit 18200, CRP 210, kreatinin 2.4, üre 138, laktat 2.4, trombosit 95000. Belirgin hipotansiyon nedeniyle sıvı resüsitasyonu sonrası noradrenalin infüzyonu başladı. Antibiyoterapi enfeksiyon hastalıkları onayıyla Meronem 3x1gr (1.gün). Kan gazı: ph 7.31 pco2 46 po2 78 hco3 21 be -3 spo2 92 sodyum 141 potasyum 4.2. Kan şekerleri 180-220 mg/dl seyretti, kristalize insülin ile regüle edildi. İdrar çıkışı diüretik infüzyonu ile yeterli, AÇT +120/24saat, CVP +2. Parenteral beslenme (+), defekasyon (-). Solunum fizyoterapisi, vücut ve kateter bakımları yapıldı. Mevcut medikal, hemodinamik ve solunum destek tedavisine devam edildi.

GLASGOW Skalası Gözler : 2 Sözel : 1 Motor : 4

06.04.2023 2.GÜN

Pnömozeptis, akut böbrek yetmezliğı tanılarıyla izlenen hastanın genel durumu kötü, GKS 7, pupiller izokorik, IR +/- . Entübe, basınç kontrol modunda (FİO2 %80, RR 15, PEEP 6) mekanik ventilatör desteğinde; dinlemekle her iki akciğer solunum sesleri kaba ve bilateral azalmış. TA 112/62 mmHg, nabız 108/dk, ateş 38.2 C. Laboratuvar: lökosit 16900, CRP 205, kreatinin 2.3, üre 132, laktat 2.3, trombosit 100000. Noradrenalin infüzyonu sürüyor, doz artırıldı. Antibiyoterapi enfeksiyon hastalıkları onayıyla Meronem 3x1gr (2.gün). Kan gazı: ph 7.32 pco2 45 po2 80 hco3 21 be -3 spo2 92 sodyum 140 potasyum 4.2. Kan şekerleri 175-215 mg/dl seyretti, kristalize insülin ile regüle edildi. İdrar çıkışı diüretik infüzyonu ile yeterli, AÇT +180/24saat, CVP +2. Parenteral beslenme (+), defekasyon (-). Solunum fizyoterapisi, vücut ve kateter bakımları yapıldı. Mevcut medikal, hemodinamik ve solunum destek tedavisine devam edildi.

GLASGOW Skalası Gözler : 2 Sözel : 1 Motor : 4

07.04.2023 3.GÜN

Pnömozeptis ve akut böbrek yetmezliğı tanılarıyla izlenen hastanın genel durumu orta-kötü, GKS 7, pupiller izokorik, IR +/- . Entübe, basınç destek modunda (FİO2 %60, PEEP 6, PEEP üstü 14) mekanik ventilatör desteğinde; dinlemekle her iki akciğer solunum sesleri kaba ve bilateral azalmış. TA 115/64 mmHg, nabız 104/dk, ateş 38.0 C. Laboratuvar: lökosit 16400, CRP 195, kreatinin 2.2, üre 128, laktat 2.2, trombosit 110000. Noradrenalin infüzyonu mevcut, doz sabit. Antibiyoterapi enfeksiyon hastalıkları onayıyla Meronem 3x1gr (3.gün). Kan gazı: ph 7.33 pco2 44 po2 82 hco3 22 be -2 spo2 93 sodyum 140 potasyum 4.1. Kan şekerleri 170-210 mg/dl seyretti, kristalize insülin ile regüle edildi. İdrar çıkışı diüretik infüzyonu ile yeterli, AÇT +240/24saat, CVP +3. Enteral beslenmeye geçildi, tolere etti. Solunum fizyoterapisi, vücut ve kateter bakımları yapıldı. Mevcut medikal, hemodinamik ve solunum destek tedavisine devam edildi.

GLASGOW Skalası Gözler : 2 Sözel : 1 Motor : 4

08.04.2023 4.GÜN

Pnömozeptis ve akut böbrek yetmezliğı tanılarıyla izlenen hastanın genel durumu orta-kötü, GKS 8, pupiller izokorik, IR +/- . Entübe, basınç destek modunda (FİO2 %55, PEEP 6, PEEP üstü 13) mekanik ventilatör desteğinde; dinlemekle her iki akciğer solunum sesleri kaba ve bilateral azalmış. TA 116/66 mmHg, nabız 100/dk, ateş 37.9 C. Laboratuvar: lökosit 13800, CRP 150, kreatinin 1.9, üre 104, laktat 2.0, trombosit 140000. Noradrenalin kademeli azaltıldı, idrar çıkışı arttı. Antibiyoterapi enfeksiyon hastalıkları onayıyla Meronem 3x1gr (4.gün), Tazocin 4x4.5gr (1.gün). Kan gazı: ph 7.35 pco2 43 po2 86 hco3 22 be -1 spo2 94 sodyum 139 potasyum 4.1. Kan şekerleri 160-200 mg/dl seyretti, kristalize insülin ile regüle edildi. İdrar çıkışı diüretik infüzyonu ile yeterli, AÇT +300/24saat, CVP +3. Enteral beslenme (+). Solunum fizyoterapisi, vücut ve kateter bakımları yapıldı. Mevcut medikal, hemodinamik ve solunum destek tedavisine devam edildi.

GLASGOW Skalası Gözler : 3 Sözel : 1 Motor : 4

09.04.2023 5.GÜN

Pnömozepte ve akut böbrek yetmezlięi tanılarıyla izlenen hastanın genel durumu orta, GKS 9, pupiller izokorik, IR +/- . Basınç destek modunda (FİO₂ %50, PEEP 6, PEEP üstü 12) mekanik ventilatör desteğinde; dinlemekle her iki akciğer solunum sesleri kaba ve bilateral azalmış. TA 118/68 mmHg, nabız 98/dk, ateş 37.8 C. Laboratuvar: lökosit 12400, CRP 120, kreatinin 1.8, üre 96, laktat 1.9, trombosit 180000. Antibiyograma göre tedaviye Tazocin eklendi, noradrenalin kademeli azaltıldı. Antibiyoterapi enfeksiyon hastalıkları onayıyla Meronem 3x1gr (5.gün), Tazocin 4x4.5gr (1.gün). Kan gazı: ph 7.36 pco₂ 42 po₂ 88 hco₃ 23 be -1 spo₂ 95 sodyum 139 potasyum 4.0. Kan şekerleri 150-190 mg/dl seyretti, kristalize insülin ile regüle edildi. İdrar çıkışı diüretik infüzyonu ile yeterli, AÇT +350/24saat, CVP +4. Enteral beslenme (+), defekasyon (+). Solunum fizyoterapisi, vücut ve kateter bakımları yapıldı. Mevcut medikal, hemodinamik ve solunum destek tedavisine devam edildi.

GLASGOW Skalası Gözler : 3 Sözel : 1 Motor : 5

10.04.2023 6.GÜN

Pnömozepte, klinik düzelme tanılarıyla izlenen hastanın genel durumu orta, GKS 11, pupiller izokorik, IR +/- . Basınç destek modunda (FİO₂ %45, PEEP 5, PEEP üstü 11) mekanik ventilatör desteğinde; dinlemekle her iki akciğer solunum sesleri kaba ve bilateral azalmış. TA 120/70 mmHg, nabız 94/dk, ateş 37.4 C. Laboratuvar: lökosit 10600, CRP 95, kreatinin 1.6, üre 78, laktat 1.7, trombosit 220000. Vazopressör ihtiyacı azaldı, weaning değerlendirildi. Antibiyoterapi enfeksiyon hastalıkları onayıyla Meronem 3x1gr (6.gün), Tazocin 4x4.5gr (3.gün). Kan gazı: ph 7.37 pco₂ 42 po₂ 89 hco₃ 23 be 0 spo₂ 95 sodyum 138 potasyum 4.0. Kan şekerleri 145-185 mg/dl seyretti, kristalize insülin ile regüle edildi. İdrar çıkışı diüretik infüzyonu ile yeterli, AÇT +320/24saat, CVP +3. Enteral beslenme tam doz. Solunum fizyoterapisi, vücut ve kateter bakımları yapıldı. Mevcut medikal, hemodinamik ve solunum destek tedavisine devam edildi.

GLASGOW Skalası Gözler : 3 Sözel : 3 Motor : 5

11.04.2023 7.GÜN

Pnömozepte, klinik düzelme tanılarıyla izlenen hastanın genel durumu orta-iyi, GKS 12, pupiller izokorik, IR +/- . Basınç destek modunda (FİO₂ %40, PEEP 5, PEEP üstü 10), weaning başlandı mekanik ventilatör desteğinde; dinlemekle her iki akciğer solunum sesleri kaba ve bilateral azalmış. TA 122/70 mmHg, nabız 90/dk, ateş 37.2 C. Laboratuvar: lökosit 10100, CRP 70, kreatinin 1.4, üre 64, laktat 1.4, trombosit 260000. Vazopressör ihtiyacı azaldı, noradrenalin çok düşük dozda. Antibiyoterapi enfeksiyon hastalıkları onayıyla Meronem 3x1gr (7.gün), Tazocin 4x4.5gr (3.gün). Kan gazı: ph 7.38 pco₂ 41 po₂ 90 hco₃ 24 be 0 spo₂ 96 sodyum 138 potasyum 4.1. Kan şekerleri 140-180 mg/dl seyretti, kristalize insülin ile regüle edildi. İdrar çıkışı diüretik infüzyonu ile yeterli, AÇT +300/24saat, CVP +3. Enteral beslenme tam doz, tolere etti. Solunum fizyoterapisi, vücut ve kateter bakımları yapıldı. Mevcut medikal, hemodinamik ve solunum destek tedavisine devam edildi.

GLASGOW Skalası Gözler : 4 Sözel : 3 Motor : 5

13.04.2023 8.GÜN

Pnömozepte, iyileşme tanılarıyla izlenen hastanın genel durumu iyi, GKS 14, pupiller izokorik, IR +/- . Ekstübe, nazal oksijen 2 lt/dk ile spontan solunumda mekanik ventilatör desteğinde; dinlemekle her iki akciğer solunum sesleri kaba ve bilateral azalmış. TA 124/72 mmHg, nabız 84/dk, ateş 36.8 C. Laboratuvar: lökosit 8100, CRP 35, kreatinin 1.2, üre 44, laktat 1.2, trombosit 320000. Vazopressör ihtiyacı kalmadı, noradrenalin kesildi. Antibiyoterapi enfeksiyon hastalıkları onayıyla Meronem 3x1gr (9.gün), Tazocin 4x4.5gr (5.gün). Kan gazı: ph 7.40 pco₂ 40 po₂ 94 hco₃ 24 be 0 spo₂ 97 sodyum 138 potasyum 4.1. Kan şekerleri 120-160 mg/dl seyretti, kristalize insülin ile regüle edildi. İdrar çıkışı diüretik infüzyonu ile yeterli, AÇT +280/24saat, CVP +2. Oral alım açıldı, mobilizasyon başlandı. Solunum fizyoterapisi, vücut ve kateter bakımları yapıldı. Mevcut medikal, hemodinamik ve solunum destek tedavisine devam edildi.

GLASGOW Skalası Gözler : 4 Sözel : 4 Motor : 6